

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: EGS_R

1. Identificación del Instrumento

Título original	Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático-Revisada (EGS-R)
Título español	Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático-Revisada (EGS-R)
Sigla	EGS-R
Autores originales	Enrique Echeburúa, Pedro J. Amor, Begoña Sarasua, Irene Zubizarreta, Francisco J. Holgado-Tello y Francisco Muñoz
Año original	2016
Adaptador español	Originalmente desarrollada en español (España)
Año adaptación	2016
Formato	Entrevista estructurada o cuestionario autoadministrado de 31 ítems

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

La EGS-R es un instrumento diseñado en España para evaluar la gravedad del TEPT en víctimas adultas expuestas a diversos acontecimientos traumáticos. Se fundamenta conceptualmente en la redefinición diagnóstica del TEPT en el DSM-5, el cual expandió los tres núcleos sintomáticos del DSM-IV a cuatro criterios principales, añadiendo el de alteraciones cognitivas y de estado de ánimo negativas.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar la presencia y gravedad de los síntomas del TEPT según el DSM-5.
Población	Adultos expuestos a sucesos traumáticos.
Administración	Administración clínica estructurada (entrevista) o autoadministrada (aprox. 15-20 minutos).
Tiempo	Estimado entre 15 y 20 minutos.
Corrección	Suma de los 21 ítems de gravedad (rango 0-63), con subescalas adicionales para disociación y funcionalidad.

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
Intrusión / Criterio B	1 al 5	Evalúa la presencia de recuerdos, sueños, reacciones disociativas (flashbacks) o malestar psicológico ante estímulos del trauma.
Evitación / Criterio C	6 y 7	Mide los esfuerzos por evitar recuerdos, pensamientos, personas, lugares u objetos asociados al trauma.
Alt. cognitivas y ánimo / Criterio D	8 al 14	Evalúa amnesia psicógena, creencias negativas persistentes, culpa distorsionada, estado emocional negativo y desapego.
Hiperactivación / Criterio E	15 al 21	Mide irritabilidad, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración y del sueño.
Especificación Disociativa	22 al 25	Evalúa síntomas adicionales de despersonalización y desrealización asociados.
Disfuncionalidad / Criterio G	26 al 31	Mide la interferencia del cuadro clínico en áreas laboral, social, familiar y salud del paciente.

5. Sistema de Puntuación

Los primeros 21 ítems que evalúan la gravedad sintomática se puntúan en una escala tipo Likert de 4 puntos (de 0 = nada a 3 = 5 o más veces por semana / extremadamente). La puntuación total de gravedad es la suma directa de estos 21 ítems (rango 0 a 63). Las secciones de síntomas disociativos (4 ítems) y disfuncionalidad (6 ítems) se puntúan de forma separada por presencia/ausencia o escala Likert de interferencia.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Una puntuación total de gravedad (ítems 1 al 21) de **20 o más puntos** sugiere la presencia clínica de TEPT de acuerdo al DSM-5. El perfil sintomático por criterio de gravedad (B, C, D, E) ayuda a guiar el plan psicoterapéutico individualizado. Las puntuaciones de disfuncionalidad (Criterio G) permiten cuantificar el grado de afectación en la vida diaria del paciente.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

La EGS-R posee propiedades psicométricas sobresalientes. Cuenta con una alta consistencia interna global (alfa de Cronbach de 0.91 para la gravedad total) y valores de alfa para las subescalas sintomáticas que oscilan entre 0.73 y 0.85. Presenta validez convergente adecuada correlacionando altamente con el Inventario de Depresión de Beck y escalas de fobia social.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

Fue creada en español por el grupo de Echeburúa, uno de los referentes más importantes en el estudio del trauma psicológico en el ámbito de habla hispana, por lo que posee una elevada validez cultural y lingüística.

9. Aplicaciones Prácticas

Evaluación clínica hospitalaria, peritajes psicológicos forenses, centros de atención a víctimas de violencia de género, atentados y accidentes graves.

10. Fortalezas del Instrumento

- Totalmente adaptada a los criterios diagnósticos actualizados del DSM-5.
- Desarrollada en español, evitando sesgos de traducción o transculturales.
- Incluye de manera integral la evaluación de síntomas disociativos y el impacto funcional.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Requiere que el suceso traumático esté claramente identificado previamente como desencadenante.
- En contextos forenses, puede requerir el uso complementario de escalas de sospecha de simulación.

12. Consideraciones Éticas y Legales

La rememoración de eventos traumáticos durante la evaluación puede generar distress psicológico; el terapeuta debe asegurar un encuadre terapéutico seguro y de apoyo.

13. Síntesis Técnica General

La EGS-R es la entrevista de referencia para la evaluación multidimensional de la gravedad sintomática y funcional del TEPT bajo el paradigma del DSM-5 en lengua castellana.

14. Referencias Bibliográfica

- Echeburúa, E., Amor, P. J., Sarasua, B., Zubizarreta, I., Holgado-Tello, F. J., & Muñoz, F. (2016). Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático según el DSM-5 (EGS-R): Propiedades psicométricas. *Terapia Psicológica*, 34(2), 111-128.